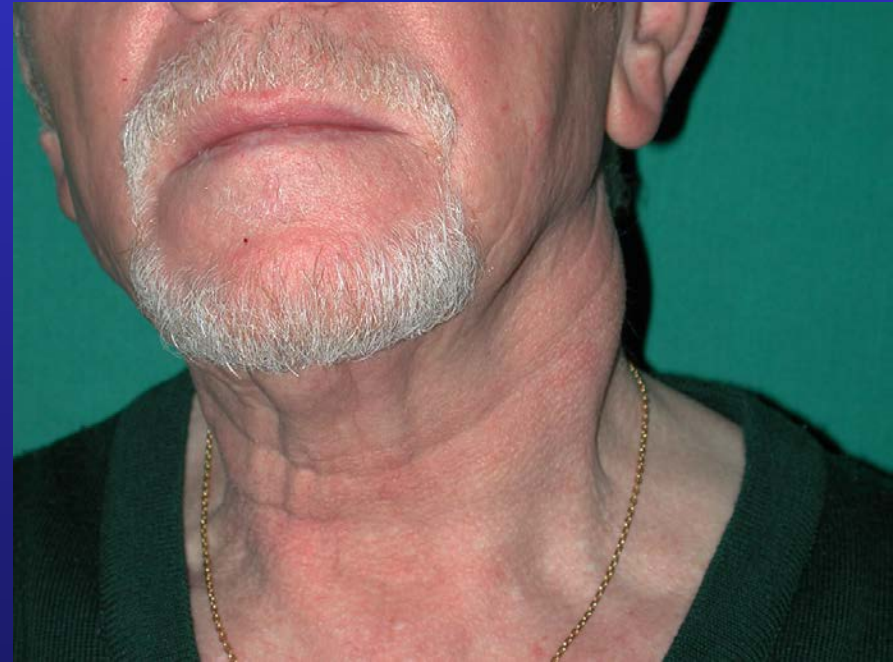


Cas clinique

Cas n° 1



Cas n° 2



Anamnèse

Cas n° 1

25 ans, étudiante

BSH, ☐ OH / tabac

Apparition depuis
1mois

Douloureux
initialement

Act. Indolore, ☐
régression

Cas n° 2

55 ans, maganisier

St. 2ans post Infarctus
myocarde / BPCO

OH / tabac

Apparition depuis
1mois

Indolore

Odynodysphagie

Status

Cas n° 1

Masse jugulaire
moy. à sup.

Peau lisse

Palpation indolore
mais fluctuante

Mobile/plan profond

Status ORL sp

Cas n° 2

Masse jugulaire
moyenne

Peau lisse

Palpation indolore
mais ferme

Fixation +/- plan
profond

Status ORL stase
salivaire hypoharynx

Risque / Diagnostic différentiel

Cas n° 1

Femme

< 40 ans

□ OH / tabac

Diag différentiel

Masse congénitale

Tumeur bénigne

Métastase

Cas n° 2

Homme

> 40 ans

OH / tabac

Diag différentiel

Métastase

Tumeur bénigne

Masse congénitale

Investigations

??????????

- Radiographie standard cou de profil
- CTScan
- IRM
- US
- Cytoponction
- Panendoscopie
- Biopsie chirurgicale

Bilan préthérapeutique

Cas n° 1

1. Cytoponction

2. +/- US

3. CT Scan

Cas n° 2

1. Cytoponction

2. IRM

3. Panendoscopie

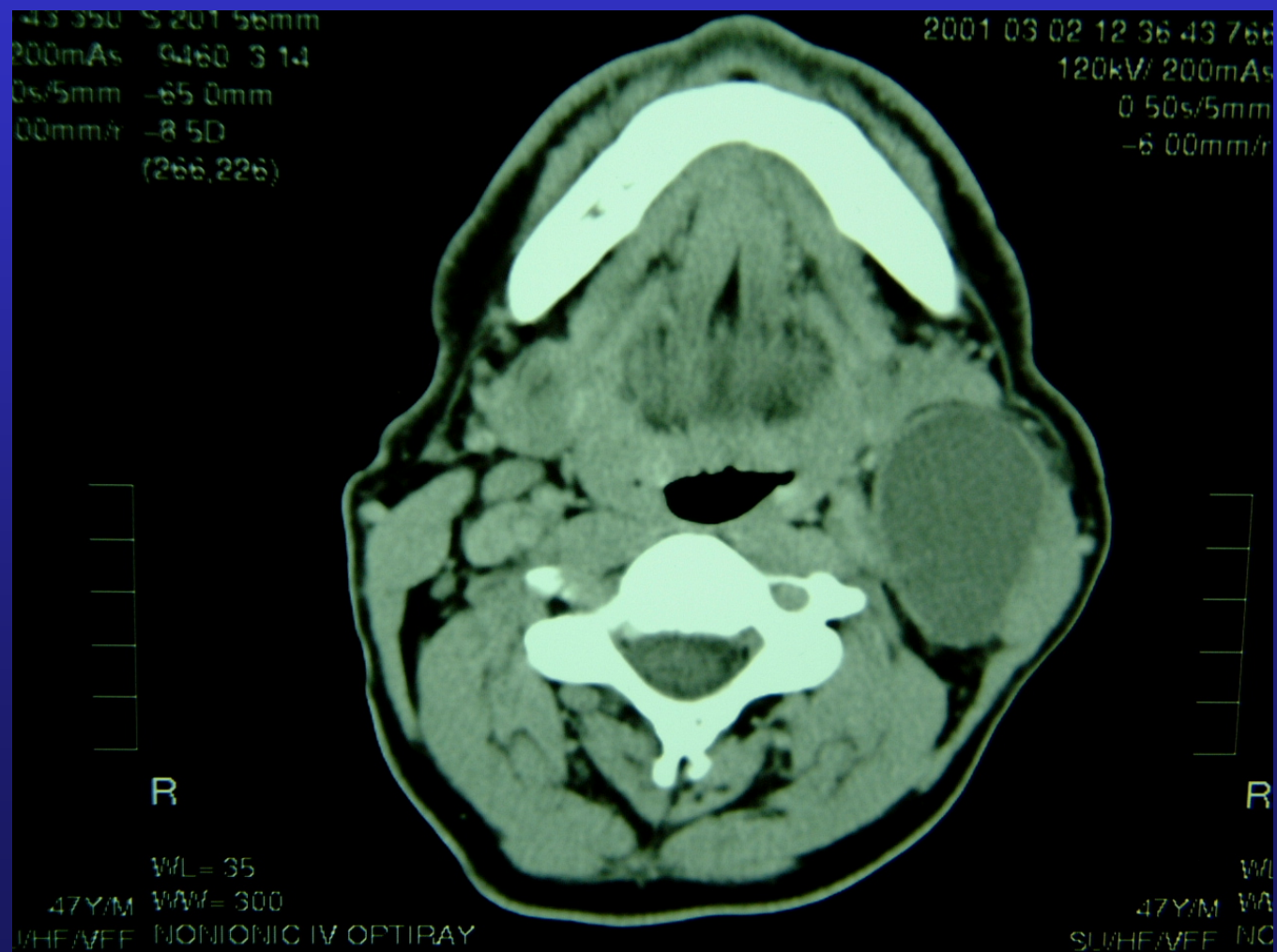
Cytoponction cas n° 2



Cytoponction cas n° 2



CT SCAN Cas n°1



Diagnostic différentiel lié à l'âge

0 – 15 ans

Inflammatoire>congénital>malin>bénin

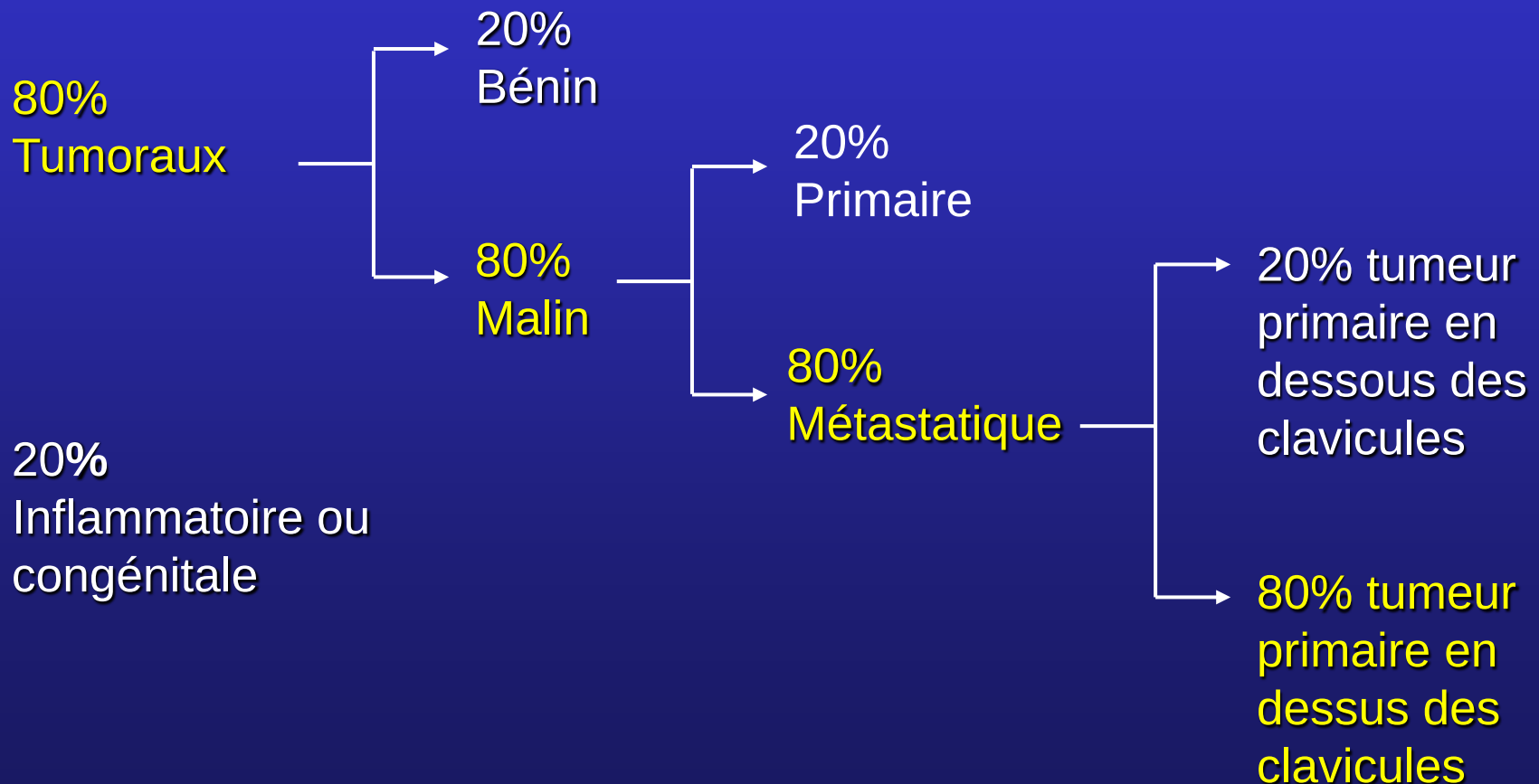
16 – 40 ans

Inflammatoire>congénital>bénin>malin

> 40 ans

malin>bénin>Inflammatoire>congénital

Diagnostic différentiel : adulte



Origine masses cervicales

70% ganglions lymphatiques

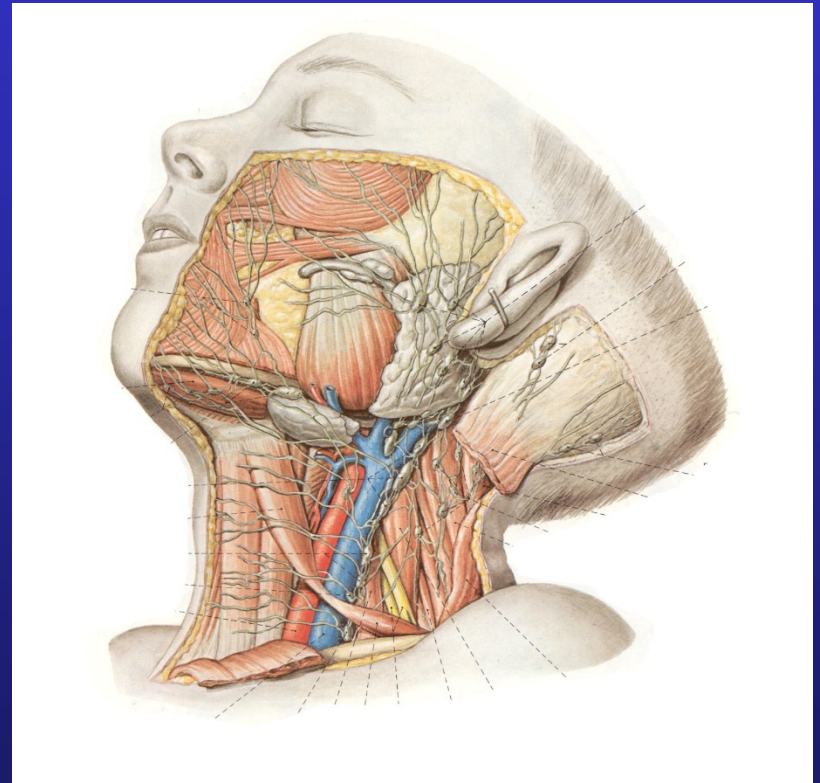
30% congénitales

glandes salivaires

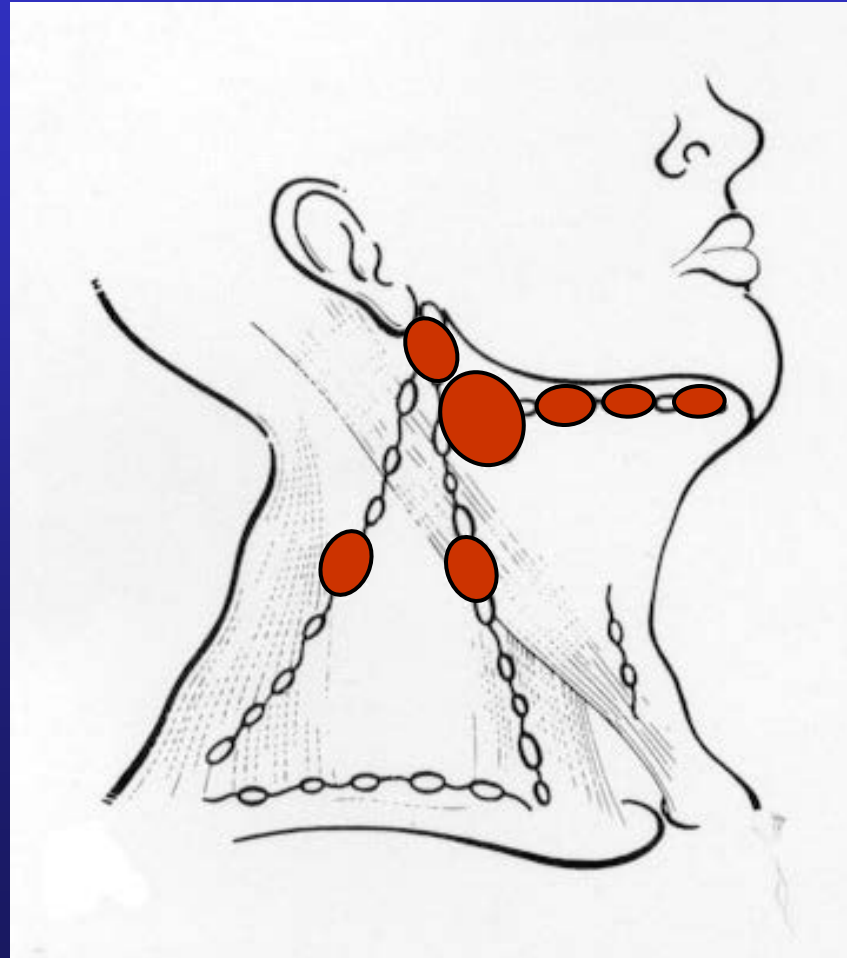
glande thyroïde

tissu vasculaire ou

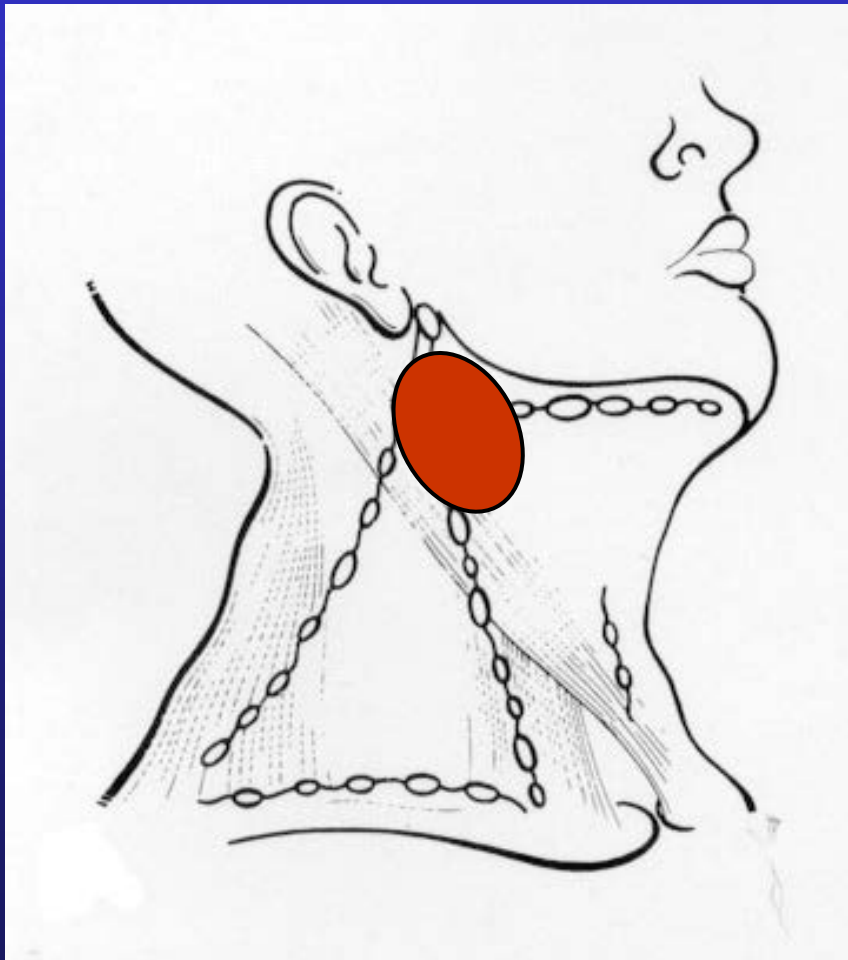
nerveux



Ganglions satellites



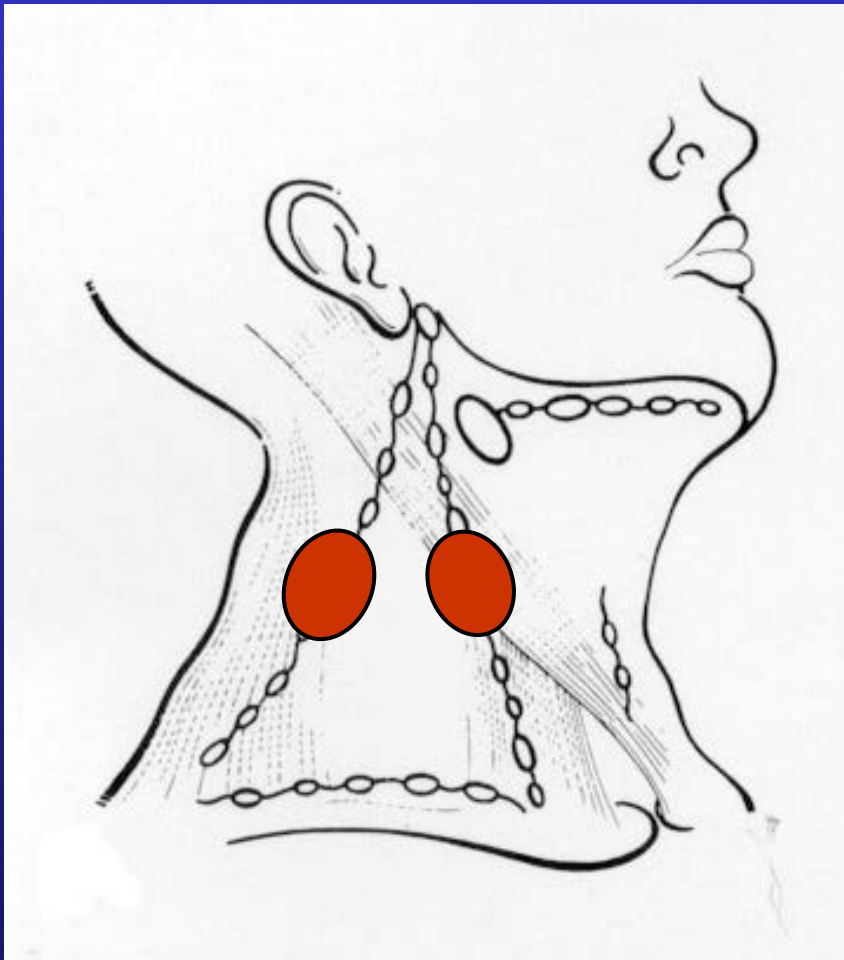
Ganglion jugulo-digastrique



Lésion primaire :

- oropharynx
- amygdale
- base de langue
- cavité buccale post.
- sinus postérieurs
- région cutanée faciale

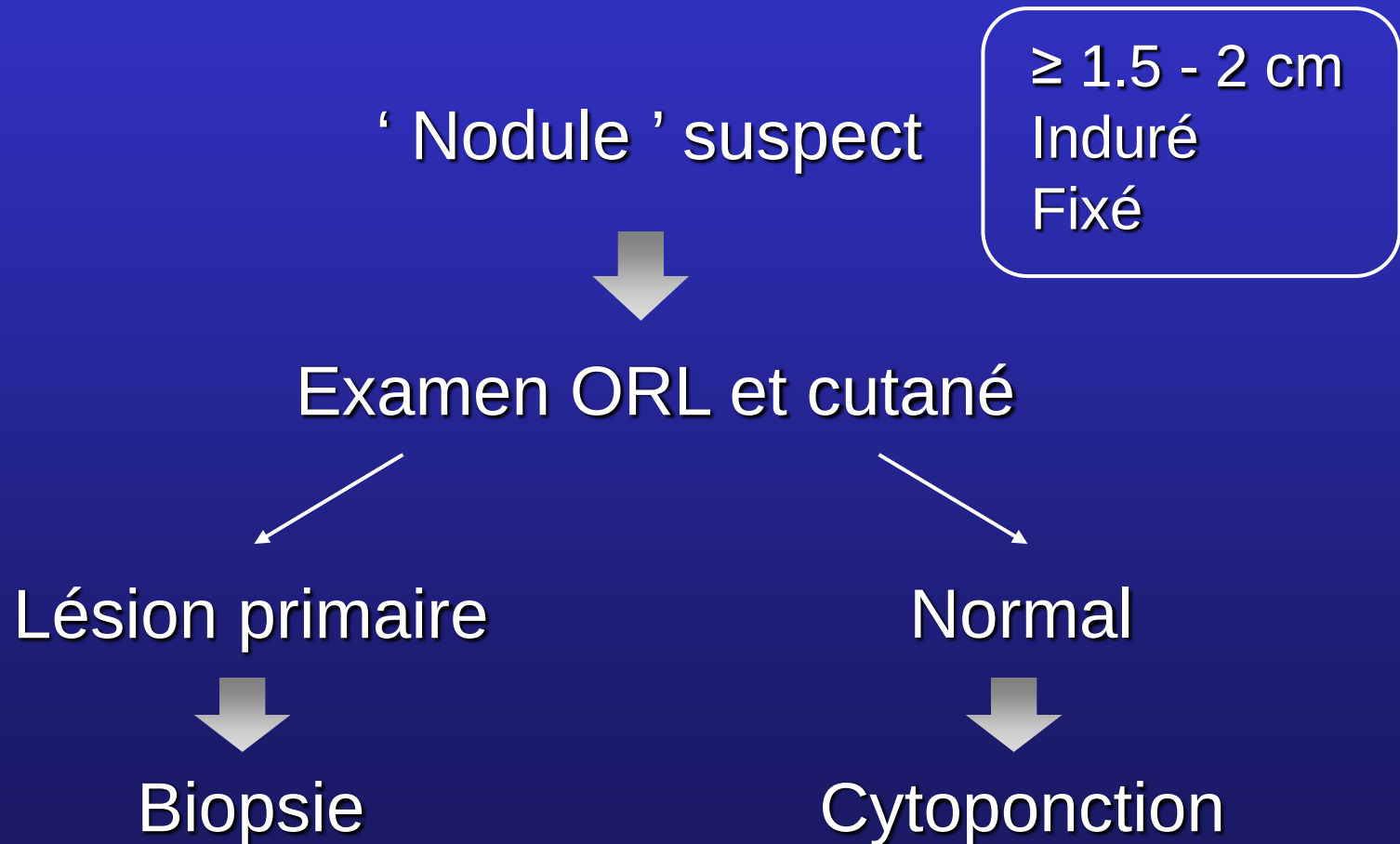
Ganglions jugulaire et spinal moyens



Lésion primaire :

- base de langue
- pharynx
- larynx

Prise en charge



« Take Home Message »

Notion de risque !!

Age / Sexe

Durée d'évolution

Mode et circonstance d'apparition

Symptômes dans la sphère ORL associés

Mode d'évolution

« Take Home Message »

- 70% masses cervicales = **GANGLIONS**
- **Diagnostic différentiel**
 - Anamnèse précise
 - Notion risques épidémiologique
 - Localisation
- **Cytoponction** à aiguille fine = examen complémentaire de choix

Qu'avez-vous retenu?

- Dans > 50% des cas une masse du cou = un ganglion ?
- Un patient de 43 ans a ½ d'avoir un cancer ?
- Le premier diagnostic d'une masse cervicale chez l'enfant est l'infection ?
- Pour l'investigation d'une masse cervical, l'examen de choix est le CT Scan cervical ?
- Si le diagnostic n'est pas clair on pratique une biopsie chirurgicale ?

CE trachéo-bronchique

- Syndrome de pénétration / toux
- Fièvre

Signes radiologiques:

emphysème obstructif
atélectasie

Indication à une bronchoscopie rigide!

Bilan radiologique

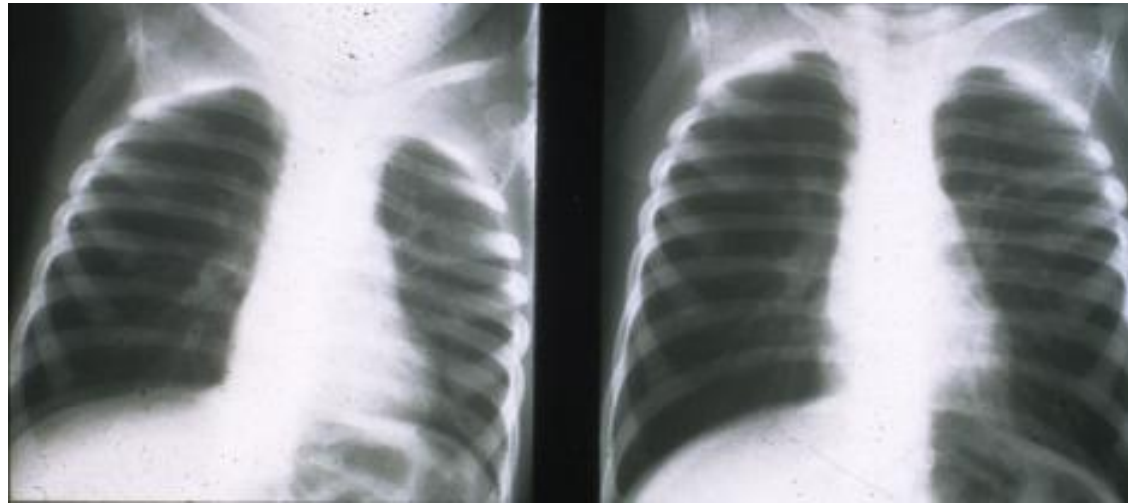
Cou profil tissus mous



CE visible	8%
Emphysème	39%
Atélectasie	10%

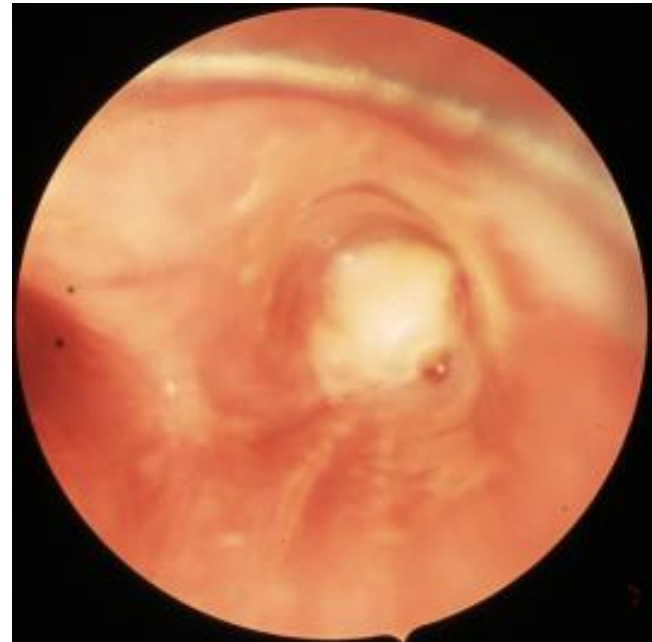
Rx thorax

Ev. in- / expiratoire



Nature du CE chez l'enfant

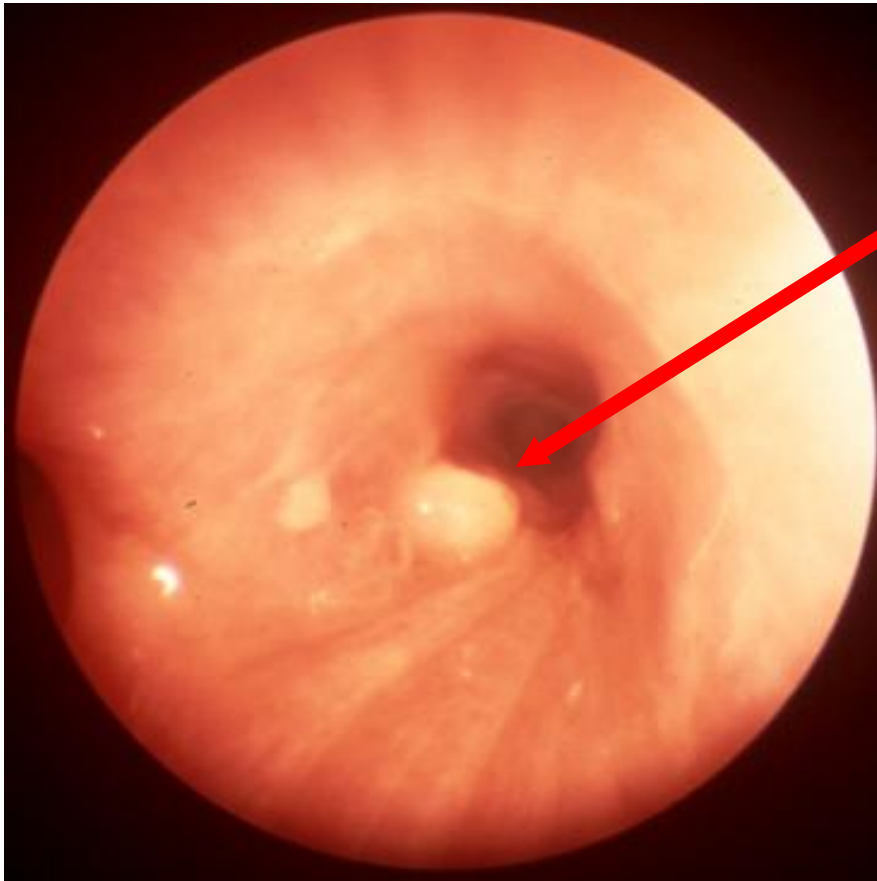
Végétal:	env 90%
cacahuète	env 50%
noisette	env 15%



En cas de suspicion de CE

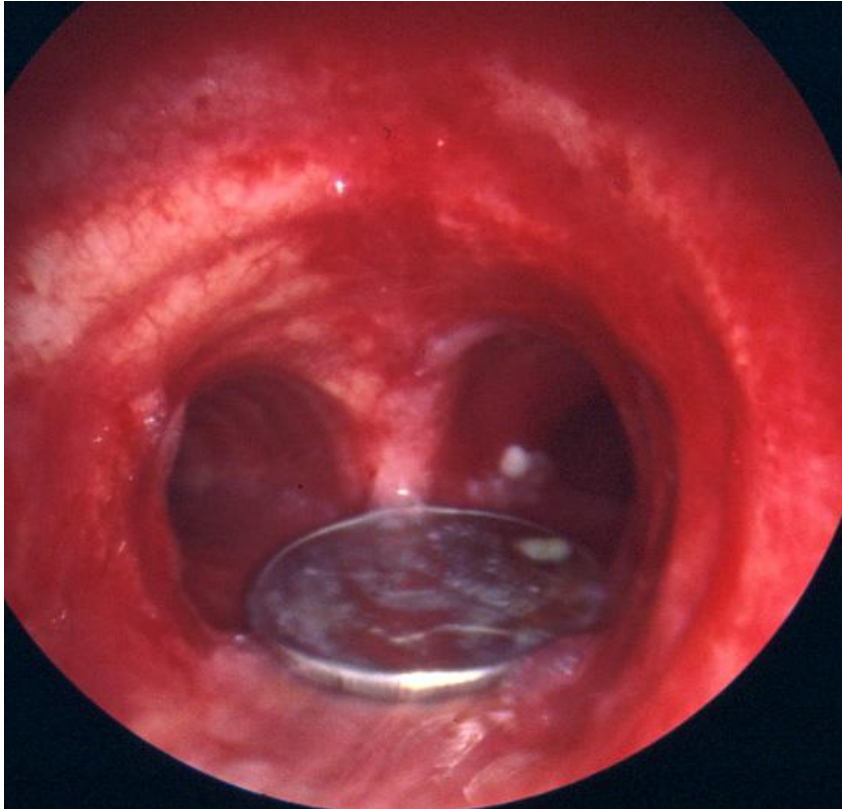


Confirmation à la bronchoscopie



**Granulation
inflammatoire 10
jours post
extraction d'un CE**

CE métallique



CORPS ÉTRANGERS

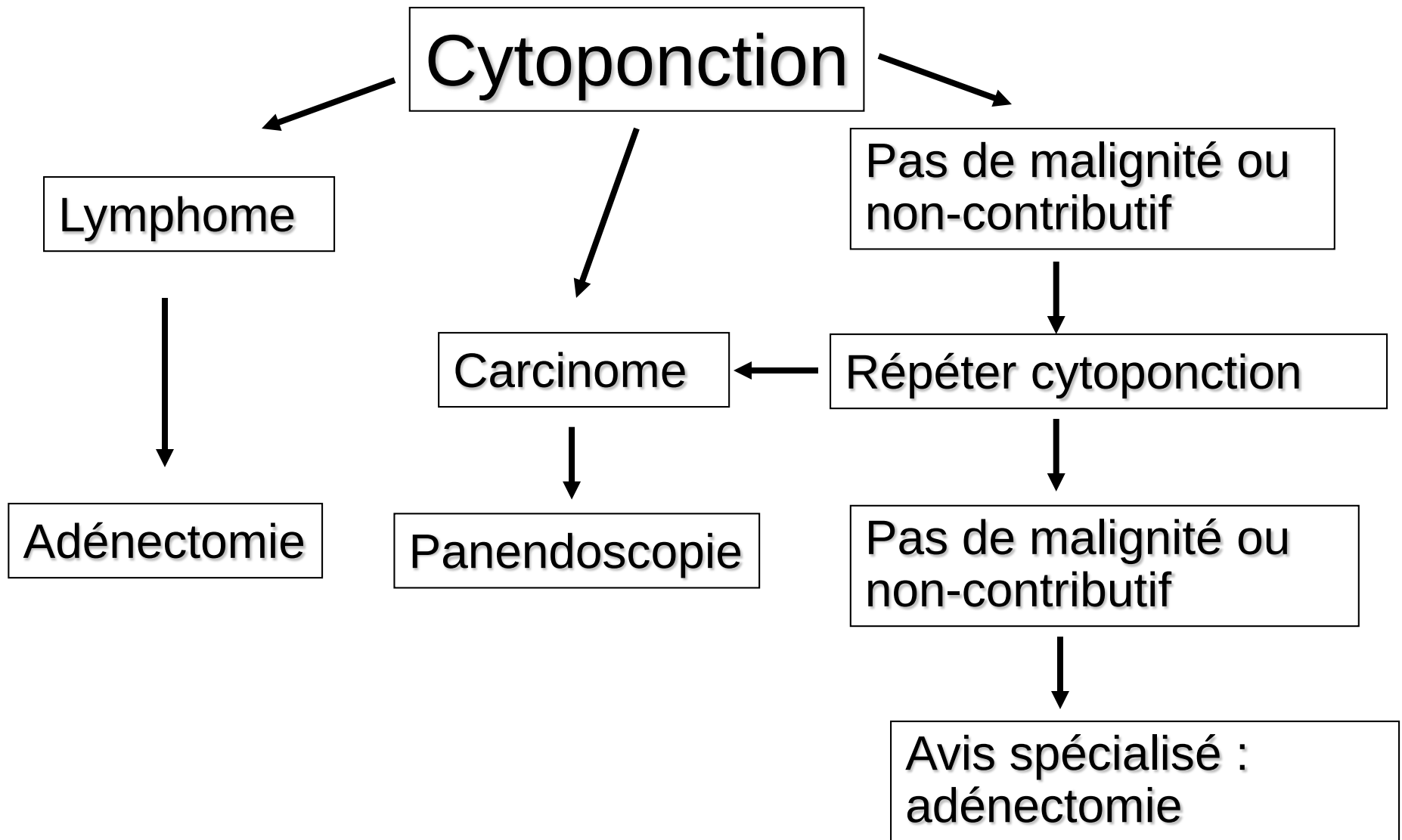
VOIES DIGESTIFS

SUPERIEUR (VDS)

- Anamnèse
- Symptomatologie
- Ex. physique :
 - laryngo. indirecte
 - palpation cervicale
 - status cardio-pulmonaire
 - T°
- Radiologie :
 - thorax F + P (debout)
 - région cervicale profil (parties molles)



ENDOSCOPIE



A proscrire!!!



Biopsie en ' quartier d 'orange ' à proscrire ! ! !